

Ensaio Conceitual

Aluna: Nainhana Dos Santos Souza

Professores: Stavros Abib e Carolina Carvalho

Disciplina: Trabalho Final de Graduação I

Data: 11/05/2026

1. INTRODUÇÃO:

A arquitetura de ambientes de saúde tem passado por uma profunda transformação, consolidando a "Arquitetura da Cura" como um campo que reconhece o espaço construído como um agente ativo na promoção do bem-estar e na recuperação do usuário. Dentro deste universo temático, o presente estudo delimita como fenômeno a "Arquitetura Paliativa", focando especificamente na intersecção entre o ambiente construído, os cuidados de fim de vida e a cidadania. Historicamente, a arquitetura hospitalar e as políticas públicas voltaram-se quase exclusivamente para a cura e a alta tecnologia biomédica, gerando uma lacuna significativa: a carência de espaços físicos adequados e de reflexão projetual voltada para acolher pacientes em estágio avançado de doença, momento em que a cura já não é mais possível. O propósito deste trabalho é investigar a relação entre arquitetura, cuidados paliativos e cidadania, evidenciando como o espaço físico (tipologia dos hospices) atua como uma ferramenta material para suprir essa falha, promovendo o alívio do sofrimento e o acolhimento.

2. JUSTIFICATIVA

Relevância Social: O aumento de doenças crônicas e irreversíveis e o envelhecimento populacional, torna a necessidade de cuidados paliativos uma urgência social crescente. Globalmente, mais de 73 milhões de pessoas necessitam desse amparo anualmente, mas apenas 14% têm acesso, resultando em 20 milhões de mortes com sofrimento evitável. Agrava-se o fato de que mais de 80% dessa demanda está concentrada em países de baixa e média renda, refletindo diretamente a realidade brasileira (ANCP, 2025). No cenário nacional, estima-se que entre 24% a 68% dos óbitos teriam necessidade de atenção paliativa. No entanto, a efetivação desse amparo esbarra em falhas estruturais do Sistema Único de Saúde (SUS), onde a integração tardia dos cuidados paliativos resulta em internações hospitalares desnecessárias e sobrecarga emocional para as famílias (ANCP, 2025).

Embora existam avanços no setor, a infraestrutura nacional ainda é insuficiente: dados atualizados, revelam que o Brasil conta com apenas 373 hospices, número que evidencia uma escassez alarmante quando comparado a países como os Estados Unidos, que dispõem de mais de 5.200 agências desse tipo para atender sua população. Esse déficit reflete-se de forma trágica no estudo global conduzido por Finkelstein et al. (2021), no qual o Brasil amarga a 79ª posição em um ranking de 81 países sobre a qualidade de morte.

Neste contexto, impulsionado pelo compromisso atual de implementação da primeira Política Nacional de Cuidados Paliativos, que estabelece a meta de criar mais de 1.300 equipes para democratizar o atendimento no país (ANCP, 2025), a relevância social deste trabalho é evidenciar a carência estrutural e propor dignidade espacial, defendendo que o acesso a um ambiente acolhedor no fim da vida é o cumprimento de um direito constitucional e a expressão máxima da cidadania.

Contribuição Técnico-Científica: No campo do desenvolvimento teórico e projetual, a revisão de literatura demonstra que os esforços da área têm se concentrado majoritariamente em ambientes curativos, existindo uma deficiência de diretrizes focadas exclusivamente no amparo à finitude da vida. A contribuição técnico-científica deste trabalho é atuar diretamente sobre essa deficiência, utilizando os referenciais teóricos da "Arquitetura da Cura", do Design Biofílico e da Ambiência Sensorial para propor um novo modelo espacial para a terminalidade. Desse modo, a pesquisa transcende a edificação isolada para fornecer diretrizes projetuais aplicáveis a três escalas essenciais: na Arquitetura, ao comprovar que o espaço construído atua como um agente terapêutico ativo, capaz de mitigar a dor e resgatar o conforto físico e emocional essenciais à tipologia dos hospices.

No Urbanismo, ao conceber o equipamento de saúde de forma integrada e sustentável à malha da cidade, utilizando o planejamento para romper o isolamento institucional dos pacientes e no Paisagismo, ao incorporar infraestruturas verdes e paisagens terapêuticas (como os jardins de cura) como ferramentas cientificamente validadas para a redução do estresse e para a reconexão humana com a natureza.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral: Desenvolver o anteprojeto arquitetônico de um centro de cuidados paliativos (hospice).

3.2 Objetivos Específicos:

- Objetivo Específico 1: Desenvolver as plantas de setorização e fluxos do Centro de Acolhimento, comprovando no desenho como os espaços atendem às necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais do paciente.
- Objetivo Específico 2: Elaborar o partido arquitetônico, volumétrico e paisagístico que materialize as diretrizes de biofilia e a ambiência acolhedora (o conceito "heymish").
- Objetivo Específico 3: Projetar e detalhar o layout interno e os espaços de convívio para atestar a promoção do controle, autonomia e territorialidade aos pacientes.

4. REVISÃO TEÓRICA

A literatura contemporânea sobre a arquitetura em saúde revela uma profunda reflexão sobre o papel do ambiente construído, distanciando-se gradativamente do modelo focado unicamente na erradicação de doenças (SIMONSEN; STURGE; DUFF, 2022). Contudo, essa visão curativa entra em colapso quando o foco transita para a terminalidade. Quando o paciente depara-se com uma doença avançada, a insistência no

a insistência no modelo estritamente clínico revela uma falha crítica, exigindo que o espaço ofereça um acolhimento que abrace as dimensões física, emocional, social e espiritual, fundamentado no conceito de "dor total" idealizado por Cicely Saunders na década de 1960 (SAUNDERS, 2004 apud SILVA; BRUM, 2022).

Diante dessa lacuna, o referencial teórico afasta-se da utopia da cura e apoia-se na urgência de uma Arquitetura Paliativa, cujo design demanda uma quebra de paradigmas espaciais e institucionais (ADAMS, 2016). A literatura tem comprovado que o conforto ambiental atua como uma necessidade clínica ativa nessa tipologia: estudos como o de Aripin (2007 apud SIMONSEN; STURGE; DUFF, 2022) demonstram a correlação direta entre o design da iluminação natural e o bem-estar do paciente, enquanto Nielsen e Overgaard (2020 apud SIMONSEN; STURGE; DUFF, 2022) atestam o valor terapêutico irrevogável da biofilia, comprovando que o acesso a vistas para a natureza exerce impacto imediato na redução da ansiedade.

O debate atual sobre o design para o fim da vida explora a transição da impessoalidade do ambiente clínico (o hospital) para a tradição do ambiente doméstico (a casa). A vanguarda desse movimento é ilustrada pelos Maggie's Centres no Reino Unido, edifícios que recusam a frieza hospitalar para introduzir o conceito de "heimish", um ambiente que transmite a sensação caseira e confortável (JENCKS; HEATHCOTE, 2010 apud ADAMS, 2016). Contudo, essa transição não é isenta de conflitos na prática projetual. Enquanto Adams (2016) defende ambientes domésticos amplamente fluidos, transparentes e focados na convivência, autores como Simonsen e Duff (2021 apud SIMONSEN; STURGE; DUFF, 2022) problematizam a aplicação irrestrita desse modelo. Em seus estudos observacionais, os autores evidenciam a tensão entre a arquitetura acolhedora e a arquitetura segura, alertando que espaços excessivamente abertos podem impactar negativamente a equipe médica, que perde áreas de refúgio fundamentais na rotina paliativa. Em contraposição à idealização absoluta do quarto individual, Folmer et al. (2012 apud SIMONSEN; STURGE; DUFF, 2022) também advertem que o isolamento físico extremo pode criar uma falsa sensação de privacidade e agravar a solidão do paciente.

Transpor esse repertório focado no cuidar e suas tensões espaciais para a realidade brasileira exige uma leitura sociopolítica profunda. No Brasil, os cuidados paliativos enfrentam graves desafios estruturais no Sistema Único de Saúde (SUS), refletidos na escassez de leitos e na concentração desigual de hospices, majoritariamente localizados no eixo Sul-Sudeste (SILVA; BRUM, 2022). Estudos globais atestam que o país ainda apresenta índices insatisfatórios na qualidade de morte e na oferta de cuidados no fim da vida, evidenciando disparidades estruturais severas (FINKELSTEIN et al., 2022).

Diante do exposto, o mapeamento da literatura revela que, embora exista um consenso sobre a necessidade de humanização espacial e a garantia dos cuidados paliativos como um direito de cidadania (MENDES, 2017 apud SILVA; BRUM, 2022), há uma forte tensão teórica sobre como equilibrar a fluidez da atmosfera doméstica com as exigências operacionais e de suporte à equipe. Essa divergência evidencia a principal lacuna que este trabalho visa explorar: a ausência de diretrizes espaciais e normativas claras para a construção de Centros de Acolhimento Paliativo na saúde pública brasileira. Se, por um lado, modelos de excelência internacionais operam majoritariamente com financiamentos privados, por outro, faz-se necessário investigar como a arquitetura pode resolver os conflitos entre ambiente doméstico e clínico, traduzindo as dimensões do alívio da dor para a realidade estrutural e econômica do SUS.

5. CONCEITOS:

5.1 Cuidados Paliativos: Etimologicamente derivada do termo latino palliare, que significa "cobrir com um manto" ou proteger, a prática paliativa constitui uma filosofia focada estritamente na qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) a define como uma abordagem de melhora da vida de pacientes e familiares diante de doenças ameaçadoras, operacionalizada por meio da prevenção e do alívio irrestrito do sofrimento. O cerne teórico deste conceito apoia-se na máxima da "Dor Total", cunhada na década de 1960 pela médica pioneira Cicely Saunders (2004). Saunders revolucionou a assistência ao desconstruir a visão puramente biológica do adoecimento, comprovando que o sofrimento do paciente terminal é multifatorial e atinge quatro dimensões inseparáveis: física, emocional, social e espiritual. Sob essa lente, o cuidado paliativo abandona a busca exclusiva pela cura para focar na mitigação holística do sofrimento, validando o conceito ético de que o paciente deve ser capacitado a viver ativamente até o seu último dia.

- Vínculo com o projeto: A setorização do anteprojeto será a tradução física da teoria da Dor Total, oferecendo desde ambientes com controle clínico termoacústico (dor física), até capelas, grandes cozinhas comunitárias e jardins terapêuticos (dores espiritual, social e emocional).

5.2 Cidadania: A cidadania A Cidadania, no contexto da saúde e da terminalidade, ultrapassa o mero exercício de direitos políticos e civis para configurar-se como o pilar ético da dignidade humana. Teoricamente, Thomas Humphrey Marshall (1950) consolida o termo através da "cidadania social", que assegura ao indivíduo os direitos inerentes a uma vida com padrão civilizado, englobando o acesso universal à saúde, ao bem-estar e à segurança. Araújo (2007) expande essa definição ao afirmar que a cidadania plena exige uma abordagem multidisciplinar que garanta a integridade física, psíquica e ideológica do sujeito diante do Estado. No âmbito do adoecimento grave e terminal, Mendes (2017) postula que a cidadania se expressa na responsabilidade intransferível do Estado de assegurar uma linha de cuidado integral, garantindo a igualdade e o respeito aos direitos humanos mesmo na finitude. O exercício pleno da cidadania na saúde significa, portanto, respeitar a autonomia e os desejos do paciente, preservando não apenas o cuidado com a vida, mas a garantia de uma morte amparada e livre de sofrimentos evitáveis.

- Vínculo com o projeto: O Centro Cuidados Paliativos materializará a cidadania social ao se posicionar como um equipamento de saúde que democratizará o acesso ao amparo, oferecendo uma estrutura física de excelência que garantirá especialmente o direito à morte digna.

5.3 Arquitetura Paliativa: A Arquitetura Paliativa é conceituada como o agenciamento do espaço construído atuando de forma ativa como um instrumento terapêutico. Historicamente estruturada na tensão entre o ambiente clínico tradicional e a idealização do ambiente doméstico, essa tipologia encontra amparo nos estudos de Annmarie Adams (2016), que destaca a urgência de romper com a assepsia e a impessoalidade da arquitetura hospitalar. Nesse arcabouço emerge o conceito de "Heymish". Em paralelo, Simonsen et al. (2022) abordam a "arquitetura de cura", cujas diretrizes espaciais buscam atenuar o estresse psicológico e a vulnerabilidade através da integração visual com a natureza e o design biofílico. Conforme atesta Frazão (2015), a arquitetura projetada para a finitude possui o poder singular de redefinir o conceito de invalidez, transformando a edificação em um agente que acomoda o luto, oferece refúgio seguro à equipe de saúde e devolve o controle do entorno ao paciente.

- Vínculo com o projeto: O partido arquitetônico adotará o conceito "Heymish" ao rejeitar superfícies industriais frias em favor de texturas aconchegantes, promovendo iluminação natural e estabelecendo as áreas de convívio livre como o coração estrutural do layout, afastando o estigma do confinamento clínico.

6. SÍNTESE INTERPRETATIVA:

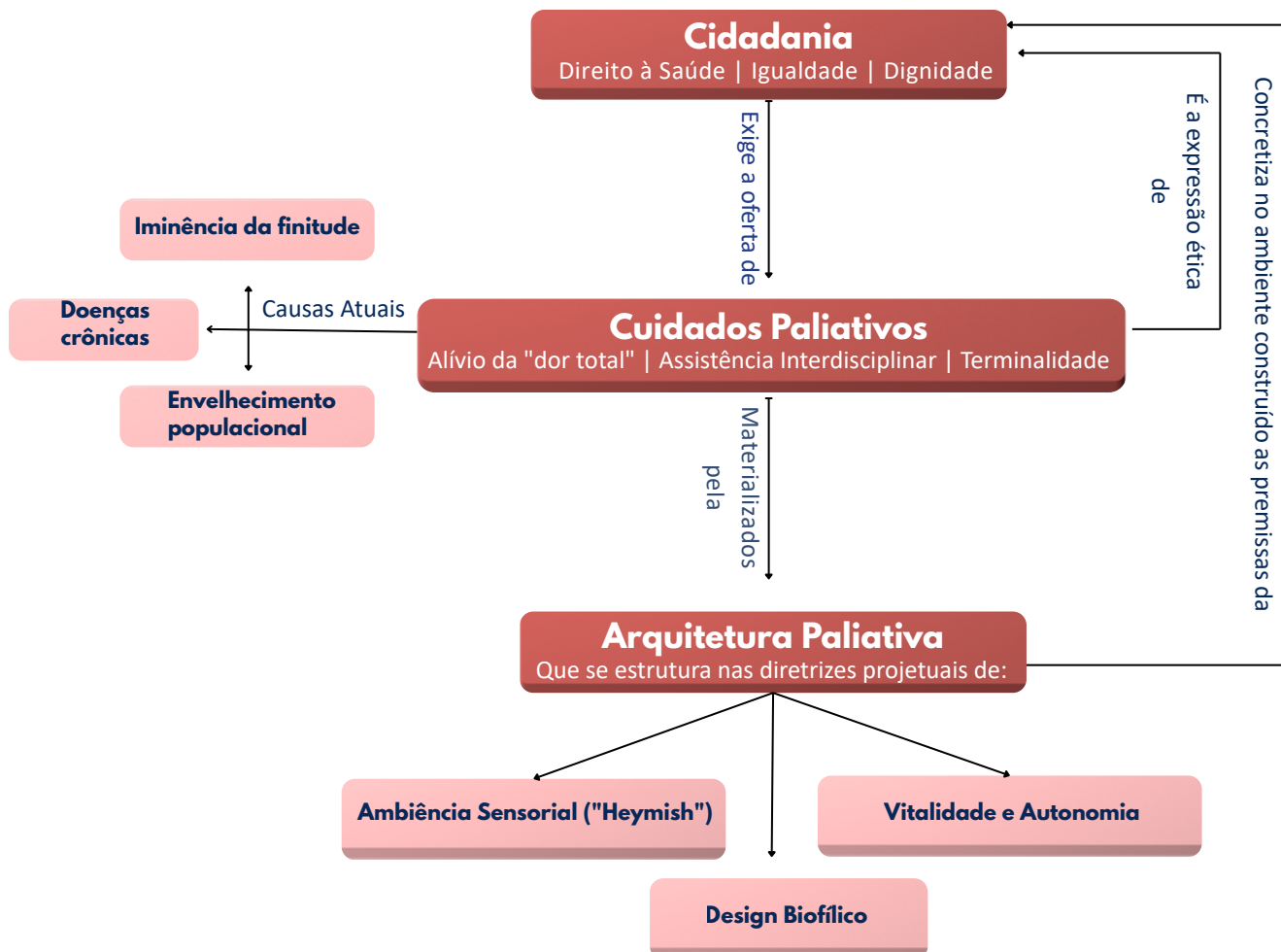
A estruturação teórica deste trabalho organiza-se através de uma relação de interdependência sistêmica e materialização entre três conceitos fundamentais: Cidadania, Cuidados Paliativos e Arquitetura Paliativa. Essa tríade não atua de forma isolada, mas em um ciclo de retroalimentação conceitual explicitado no diagrama.

O primeiro eixo dessa relação é ético: a Cidadania, fundamentada no direito à saúde, igualdade e dignidade, atua como o alicerce que exige a oferta dos Cuidados Paliativos. Em via de mão dupla, os Cuidados Paliativos, focados no alívio da "dor total" e na assistência interdisciplinar na terminalidade, são a expressão ética máxima da cidadania, garantindo que o sujeito não seja abandonado diante da finitude.

O segundo eixo é de materialização. As práticas de alívio e conforto exigidas pelos Cuidados Paliativos são diretamente materializadas pela Arquitetura Paliativa. É através da aplicação de diretrizes projetuais específicas, como a adoção do design biofílico, a promoção de vitalidade e autonomia, e o estabelecimento da ambiência caseira "heymish", que a filosofia do cuidado ganha forma espacial.

Por fim, o terceiro eixo é o de concretização, fechando o ciclo. A Arquitetura Paliativa concretiza no ambiente construído as premissas da Cidadania. Desse modo, a arquitetura abandona o papel de mero abrigo passivo para atuar como o instrumento ativo que viabiliza o acolhimento, assegurando espacialmente o direito à dignidade humana do paciente e de sua família até o fim da vida.

7. DIAGRAMA



8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS (ANCP). Brasil se une ao mundo pelo acesso universal aos cuidados paliativos. Portal ANCP, 10 out. 2025. Disponível em: <https://paliativo.org.br/brasil-se-une-ao-mundo-pelo-acesso-universal-aos-cuidados-paliativos/>. Acesso em: 03 maio 2026.

ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS (ANCP). Hospices no Brasil ainda se concentram no eixo Sul-Sudeste. Portal ANCP, 17 dez. 2024. Disponível em: <https://paliativo.org.br/hospices-no-brasil-ainda-se-concentram-no-eixo-sul-sudeste/>. Acesso em: 05 maio 2026.

ADAMS, Annmarie. Home and/or hospital: the architectures of end-of-life care. *Change Over Time*, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 248-262, out. 2016. DOI: 10.1353/cot.2016.0016.

FINKELSTEIN, Eric A. et al. Cross Country Comparison of Expert Assessments of the Quality of Death and Dying 2021. *Journal of Pain and Symptom Management*, [S. l.], v. 63, p. e419-e429, 2022.

SILVA, Fernanda Corrêa da; BRUM, Cristhian Moreira. Arquitetura para cuidar: uma abordagem sobre espaço, cuidado terapêutico e cidadania. *Pixo – Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade*, Pelotas, v. 6, n. 22, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/pixo/article/view/25473/18887>.

SIMONSEN, Thorben; STURGE, Jodi; DUFF, Cameron. Arquitetura de cura em saúde: uma revisão abrangente. *Health Environments Research & Design Journal*, [S. l.], p. 1-14, 2022.

SIMONSEN, Thorben Peter Høj; BROWN, Steven D.; REAVEY, Paula. Vitality and nature in psychiatric spaces: Challenges and prospects for ‘healing architecture’ in the design of inpatient mental health environments. *Health & Place*, v. 85, 103169, 2024. DOI: 10.1016/j.healthplace.2023.103169.